

Diverticulite aguda · Hinchey e conduta

Diverticulite esquerda no idoso é clássica. TC classifica complicação; não complicada pode ser conservadora, abscesso pode drenar e peritonite vai à cirurgia.

Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

TC com contraste é o exame de escolha na suspeita. Colonoscopia não na fase aguda — agende após resolução para excluir neoplasia.

Escale terapia conforme imagem e status sistêmico — Hinchey orienta a prova.

Diverticulite por gravidade

Não complicada / abscesso / peritonite

Não complicada

Dor FIE + inflamação
ATB +/- ambulatorio
Dieta e analgesia

Maioria

Abscesso

Coleção localizada
ATB + drenagem se >3-5 cm
Cirurgia se falha

Hinchey I-II

Peritonite

Furada com difusão
Ressuscitação + ATB
Cirurgia urgência

Hinchey III-IV

Pontos de conduta

- Não complicada selecionada: manejo conservador; ATB nem sempre obrigatório em imunocompetentes leves (fique atento ao que a banca adota)
- Abscesso: drenagem percutânea quando acessível e tamanho significativo
- Cirurgia de urgência: Hartmann ou anastomose primária conforme estabilidade e contaminação
- Recorrências frequentes / complicações: eletiva individualizada

Hinchey (resumo)

Grau | Achado

0 / I | Flegmão / abscesso pericólico

II | Abscesso pélvico / distante

III | Peritonite purulenta

IV | Peritonite fecal

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não faça colonoscopia na diverticulite aguda — risco de perfuração. Primeiro episódio 'típico' no jovem ou alarm signals: exclua outras causas e programe avaliação colônica após.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Diverticulite aguda: Hinchey classifica complicação e guia ATB, drenagem ou cirurgia.

I–II: muitas vezes ATB ± drenagem. III–IV: peritonite — cirurgia de urgência.

Hinchey - diverticulite

Classificação de complicação

I - abscesso / fleímao pericólico	ATB +/- drenar
II - abscesso pélvico / distante	Drenagem + ATB
III - peritonite purulenta	Cirurgia
IV - peritonite fecal	Cirurgia

I abscesso pericólico | II abscesso distante | III purulenta | IV fecal

Clínica e diagnóstico

Lembre - Clínica e diagnóstico

Dor em FIE, febre, alteração do hábito intestinal. TC com contraste é o exame de escolha para confirmar e estadiar.

Conduta por gravidade

- Não complicada: ATB ± ambulatorial se estável e sem comorbidade grave
- Abscesso: ATB; drenagem percutânea se >~3–4 cm (critério usual de prova)
- Peritonite (Hinchey III/IV): ressuscitação + cirurgia (Hartmann ou anastomose selecionada)
- Colonoscopia: após resolução do quadro agudo, para excluir neoplasia quando indicado

Sinais de gravidade

Achado | Significado

Ar livre / extravasamento | Perfuração

Abscesso | Hinchey I–II

Líquido livre / peritonite | Cirurgia

Fístula / estenose | Doença crônica complicada

Prova

Dica - Prova

Não faça colonoscopia na fase aguda de diverticulite — risco e baixo rendimento.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1